

CAPÍTULO 8.8

Úlcera Perforada, Perforación Esofágica e Ingesta de Soda Cáustica

PERFIL EUNACOM 1.06.2.001

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Úlcera Perforada, Perforación Esofágica e Ingesta de Cáusticos

1. Úlcera Gastroduodenal Perforada

Clínica

- **Antecedente:** síndrome ulceroso previo (epigastralgia urente que aumenta con ayuno)
- **Perforación:** dolor epigástrico en "puñalada" o irradiado al dorso → rápida extensión a todo el abdomen
- Signos de peritonitis graves: abdomen en tabla, Bloomberg (+), rigidez muscular, abolición de ruidos hidroaéreos
- Lo que se escapa al peritoneo es el contenido ácido del estómago → muy irritante

Diagnóstico

- **Rx de tórax de pie** (primera elección): buscar **neumoperitoneo** (aire bajo el diafragma)
- Si no aparece Rx de tórax → Rx de abdomen de pie también es válida
- La Rx de tórax es preferible porque la penetrancia para ver el aire es mejor

NOTA CLÍNICA

En la Rx de tórax: lo que está bajo el hemidiafragma **derecho** es siempre patológico (neumoperitoneo). Lo que está bajo el izquierdo puede ser la burbuja gástrica normal.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

La **endoscopia** está **contraindicada** en la úlcera perforada. El aire insuflado empeora la filtración al peritoneo.

Tratamiento

TABLA 8.8.1: MEDIDA VS DETALLE

MEDIDA	DETALLE
Cirugía de urgencia	Primera prioridad: sutura de la úlcera + parche de epiplón
Suero fisiológico EV	Reposición de volumen
IBP endovenoso	Reduce secreción ácida
Antibióticos de amplio espectro	Ceftriaxona + Metronidazol (peritonitis)
Erradicación H. pylori	En segunda instancia (evita recurrencia)

EUNACOM CRITERIOS

Si en las alternativas aparecen suero + antibióticos + omeprazol + cirugía → la respuesta **siempre es la cirugía**. Las demás son complementarias, no el tratamiento principal.

2. Perforación Esofágica

Causas (frecuentes en EUNACOM)

- **Iatrogenia por endoscopia** (causa más frecuente en la actualidad)
- Cuerpo extraño esofágico (ej. hueso de pollo)
- **Síndrome de Boerhaave:** perforación espontánea por vómitos a repetición

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Distinción clave: - Vomitar mucho → hematemesis después → **Síndrome de Mallory-Weiss** - Vomitar mucho → dolor torácico + enfisema subcutáneo + cuadro séptico → **Síndrome de Boerhaave** (perforación esofágica)

Clínica (Tríada)

- **Disfagia** (tragar difícil/doloroso)
- **Dolor torácico** (o cervical si la perforación es cervical)
- **Enfisema subcutáneo** (aire en piel, se palpa crepitante)

Diagnóstico

- **Rx de tórax** (primera línea): buscar **neumomediastino** + enfisema subcutáneo
- **TAC de tórax** (segunda línea): cuando la Rx es negativa pero la clínica es muy sugerente; evalúa mediastinitis
- **Endoscopia:** **CONTRAINDICADA** (puede agravar la perforación y aumentar la filtración al mediastino)

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

No hacer endoscopia ante sospecha de perforación esofágica. El examen inicial es la Rx de tórax.

Complicación Principal

Mediastinitis aguda: dolor torácico + **sepsis** grave + abscesos mediastínicos en TAC → muy alta mortalidad.

Tratamiento

- **Cirugía de urgencia** (regla general)
- Régimen cero
- Antibióticos de amplio espectro
- Suero fisiológico + analgesia
- **Excepción (tratamiento conservador):** perforación muy pequeña en ayunas, paciente evoluciona bien → régimen cero + suero + antibióticos, esperar cicatrización espontánea

3. Ingesta de Cáusticos (Soda Cáustica)

Clínica

- Dolor + edema desde boca hasta abdomen (labios, faringe, esófago, estómago)
- Hemorragia digestiva alta (si ulcera un vaso)
- Peritonitis si hay perforación de víscera

Manejo Inicial

- **Endoscopia urgente** (primera medida, lo más precoz posible)
- Con la endoscopia se decide el manejo:

TABLA 8.8.2: HALLAZGO ENDOSCÓPICO VS CONDUCTA

HALLAZGO ENDOSCÓPICO	CONDUCTA
Normal	Observación + líquidos vía oral
Inflamación	Régimen cero + nutrición parenteral total + endoscopia de control
Necrosis o perforación	Régimen cero + cirugía de urgencia + nutrición parenteral total

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Contraindicado en cáusticos: - **Carbón activado** (contraindicado en ingesta de álcalis y ácidos) - **Lavado gástrico** (el daño ya ocurrió, es inmediato; además puede agravar las lesiones)

EUNACOM CRITERIOS

El manejo inicial no es la cirugía → es la **endoscopia**. Con la endoscopia se decide si se opera o no según la gravedad del daño.

Si el Esófago queda destruido

- Reconstrucción quirúrgica: neo-esófago con estómago o colon

Resumen Comparativo

TABLA 8.8.3: PATOLOGÍA VS EXAMEN DIAGNÓSTICO			
PATOLOGÍA	EXAMEN DIAGNÓSTICO	TRATAMIENTO PRINCIPAL	CONTRAINDICACIÓN
Úlcera perforada	Rx tórax de pie (neumoperitoneo)	Cirugía urgente	Endoscopia
Perforación esofágica	Rx tórax (neumomediastino)	Cirugía urgente	Endoscopia

| Ingesta de cáusticos | Endoscopia urgente | Según hallazgo | Carbón activado, lavado gástrico |

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Hombre de 52 años con antecedente de uso crónico de Ketoprofeno por lumbago presenta inicio súbito de dolor epigástrico lacerante de intensidad 10/10 en 'puñalada', que se generaliza rápidamente a todo el abdomen. Al examen: vientre 'en tabla' con contractura abdominal involuntaria difusa y dolor intenso a la descompresión (signo de Blumberg generalizado). Radiografía de tórax de pie muestra aire libre subdiafragmático bilateral (neumoperitoneo)."

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Úlcera Péptica Perforada: complicación aguda grave del uso de AINEs. La presencia de peritonitis difusa con neumoperitoneo en radiografía de tórax confirma abdomen agudo quirúrgico. Manejo inmediato: Régimen cero + Sonda nasogástrica a caída libre + Hidratación enérgica con cristaloides + Antibióticos EV de amplio espectro (Ceftriaxona + Metronidazol) + Laparotomía exploradora de urgencia para rafia de la úlcera y parche de Graham.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Úlcera perforada: dolor en puñalada + peritonitis grave; diagnóstico con Rx tórax de pie (neumoperitoneo); cirugía urgente
- Perforación esofágica: tríada dolor + vómitos + enfisema subcutáneo; Rx tórax (neumomediastino); endoscopia contraindicada
- Causa más frecuente de perforación esofágica: iatrogénica (endoscopia)
- Boerhaave (vómitos→perforación) vs Mallory-Weiss (vómitos→hematemesis): no confundir
- Complicación más grave de perforación esofágica: mediastinitis aguda (TAC de tórax)
- Ingesta de cáusticos: endoscopia urgente; carbón activado y lavado gástrico contraindicados
- Manejo según endoscopia: normal=observar, inflamación=régimen cero+NPT, necrosis/perforación=cirugía

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (ÚLCERA PERFORADA, PERFORACIÓN ESOFÁGICA E INGESTA DE SODA CÁUSTICA)**PREGUNTA 1**

Paciente con antecedente de epigastralgia crónica que consulta por dolor epigástrico súbito tipo puñalada con abdomen en tabla. ¿Cuál es el examen inicial más adecuado?

- A)** Endoscopia digestiva alta de urgencia
- B)** Radiografía de tórax de pie
- C)** TAC de abdomen y pelvis
- D)** Ecografía abdominal
- E)** Hemograma y PCR

PREGUNTA 2

Paciente que tras múltiples episodios de vómitos presenta dolor torácico intenso y enfisema subcutáneo cervical. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A)** Síndrome de Mallory-Weiss
- B)** Perforación esofágica (Boerhaave)
- C)** Infarto agudo al miocardio
- D)** Neumotórax espontáneo
- E)** Disección aórtica

PREGUNTA 3

Niño de 3 años que ingirió soda cáustica hace 2 horas. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

- A)** Lavado gástrico urgente
- B)** Carbón activado por vía oral
- C)** Endoscopia digestiva alta urgente
- D)** TAC de abdomen
- E)** Cirugía exploratoria

RESUMEN: ÚLCERA PERFORADA, PERFORACIÓN ESOFÁGICA E INGESTA DE SODA CÁUSTICA

Clase sobre tres emergencias digestivas: úlcera perforada (peritonitis grave con neumoperitoneo, diagnóstico con radiografía de tórax de pie, cirugía urgente), perforación esofágica (dolor torácico + vómitos + enfisema subcutáneo, diagnóstico con radiografía de tórax buscando neumomediastino, complicación grave = mediastinitis, endoscopia contraindicada) e ingesta de soda cáustica (manejo con endoscopia urgente para evaluar daño, carbón activado y lavado gástrico contraindicados). En la perforación esofágica, la causa más frecuente es iatrogénica (endoscopia). No confundir con Mallory-Weiss (vómitos→hematemesis) vs Boerhaave (vómitos→dolor torácico + enfisema + sepsis). La ingesta de cáusticos se maneja según hallazgos endoscópicos: normal = observación, inflamación = régimen cero + NPT, necrosis/perforación = cirugía urgente.